

SEMIOLÓGÍA NEUROLÓGICA

SÍNDROMES MOTORES

Hay muchos síndromes distintos que pueden afectar la parte motora. Se debe recordar que hay 2 motoneuronas:

- 1) La **primera** tiene su soma en la corteza motora (lóbulo frontal) y su axón se decusa en el bulbo raquídeo, para luego viajar por el haz corticoespinal, hasta llegar al asta anterior de la médula contralateral, donde hace sinapsis con la segunda mononeurona. Así, está en el sistema nervioso central (SNC)
- 2) La **segunda** tiene su soma en el asta anterior de la médula y sale por el nervio periférico, hasta llegar al músculo. Así, está en el sistema nervioso periférico (SNP).

Síndrome de primera motoneurona o síndrome piramidal

Se produce por lesión del SNC y suele manifestarse como hemiparesia (cuando se afecta el cerebro o el troncoencéfalo), pero también puede ser como tetraparesia o paraparesia (cuando se afecta la médula espinal).

- * La etapa **crónica** se caracteriza por aumento del tono muscular, de tipo espástico, con exaltación de los reflejos osteotendíneos (ROT), clonus (reflejo que se repite y perpetúa) y signo de Babinsky (reflejo plantar extensor). Además puede tener atrofia, aunque esta no suele ser muy severa, ya que se mantiene cierto grado de estimulación medular por la segunda motoneurona.
- * La etapa **aguda**, en cambio, tiene hiporreflexia e hipotonía, aunque sí tiene Babinsky. Suele durar algunos pocos días, luego de la lesión.

Síndrome de segunda motoneurona o de denervación

Se produce afectación del nervio periférico, por diversas causas. Se caracteriza por hipotonía, hiporreflexia, fasciculaciones y atrofia muscular marcada.

Esclerosis lateral amiotrófica (ELA)

Se produce por degeneración del asta anterior de la médula, donde hacen sinapsis las dos motoneuronas. Así, su clínica incluye manifestaciones mezcladas de ambas motoneuronas (debilidad, con atrofia, fasciculaciones, pero con hiperreflexia e hipertonia. Además es característico que haya disfasia ilógica y fascies inexpresiva. No tiene afectación sensitiva.

Neuropatía vs Miopatía

- Neuropatía: Se caracteriza por debilidad de predominio distal, atrofia y además puede tener hipoestesia u otras alteraciones sensitivas, como dolor neuropático (urente, con alodinia: dolor quemante al roce). En general tiene clínica de segunda motoneurona.
- Miopatía: Se caracteriza por debilidad de predominio proximal, con hipertrofia o eutrofia y sin síntomas sensitivos.

Alteraciones de la placa motora: Miastenia gravis vs miastenia de Lambert Eaton

- Miastenia gravis: Tiene debilidad fluctuante, que aumenta con los movimientos repetitivos. Además suele tener mucho compromiso de los ojos, tanto con ptosis, como con estrabismo. Solo afecta los músculos estriados (anticuerpos son contra el receptor nicotínico). Es más frecuente en mujeres jóvenes y se asocia a timoma.
- Miastenia de Lambert Eaton: Tiene una clínica similar a la miastenia gravis, pero con dos diferencias importantes: 1. La debilidad disminuye con los movimientos repetitivos y 2. también afecta el sistema nervioso autónomo (ej. constipación o afectación pupilar, ya que tiene anticuerpos contra los canales de calcio presinápticos). Se asocia a cáncer pulmonar de células pequeñas.

Síndrome extrapiramidal

Se produce por enfermedades degenerativas, pero también por consumo de fármacos (antipsicóticos, metoclopramida, flunarizina). El sistema piramidal ayuda a coordinar los movimientos y su afectación se traduce en distintas formas:

- **Enfermedad de Parkinson:** Suele presentar la triada de temblor de reposo asimétrico, bradiquinesia (lentitud) y rigidez. Sin embargo además es frecuente que desaparezcan o disminuyan los movimientos involuntarios normales, como el braceo, el pestañeo, la expresión facial (hipomimia) y la escritura (micrografía: escribe con letra pequeña). La rigidez puede ser "en rueda dentada". La marcha suele ser con pasos cortos.
- **Parkinsonismo por drogas:** Similar a lo anterior, pero en contexto de uso de antidopaminérgicos. Además, el temblor suele ser simétrico.
- **Distonía:** Contracción tónica de un grupo muscular, que puede ser dolorosa. Los ejemplos clásicos son la tortícolis espasmódica (contracción de los músculos del cuello, con desviación y dolor y el espasmo del escribiente (contracción de los músculos de la mano, al escribir).
- **Balismo:** Movimiento súbito de la zona proximal de las extremidades (ej. levantar los brazos súbitamente).
- **Atetosis:** Movimientos distales de las extremidades, de tipo "reptante" o "serpenteante".
- **Disquinesia tardía:** Aparece luego de varios meses o años de tomar antipsicóticos. Presenta movimientos involuntarios, reptantes en extremidades y en la cara, en especial en la lengua y en la boca (mastica o mueve los labios y saca la lengua). No mejora del todo, al retirar los fármacos.
- **Acatisia:** Inquietud psicomotora y cambios continuos de posición, que puede venir asociado a disestesias. Suele iniciar algunos días después de iniciar los fármacos.
- **Corea:** Movimientos involuntarios de las extremidades y el tronco, que parecen un baile. Además tienen disminución de la coordinación de ciertos movimientos. Además de los síndromes extrapiramidales por fármacos, hay dos patologías que suelen tener corea:
 - Corea de Sydenham: Característica de los niños, luego de una infección estreptocócica. Es parte de la enfermedad reumática. Suele durar algunos meses y se resuelve espontáneamente. Además de los síntomas motores, puede tener labilidad emocional.
 - Corea de Huntington: Característica de adultos, con antecedentes familiares (es autosómica dominante, con letalidad de 100% y sobrevida promedio de 20 años desde los síntomas). Además de los movimientos involuntarios presenta cambios en la personalidad y demencia.

Síndrome cerebeloso

Si se altera un hemisferio cerebeloso, se suele producir adiadococinesia (imposibilidad de realizar movimientos alternantes) y dismetría (también llamado temblor de intención), en las extremidades ipsilaterales. Además suele haber hipotonía.

Si se altera el vermis cerebeloso, se produce vértigo de tipo central (con nistagmo multidireccional y caídas en todas las direcciones), ataxia de la marcha (aumento de la superficie de sustentación y descoordinación, como si estuviese borracho).

TEMBLOR

Temblor esencial: El temblor suele ser en las manos, de alta frecuencia (rápido) y aumenta al tomar un objeto o al adoptar una postura (temblor postural). Puede tener temblor de la cabeza y del mentón. El resto del examen neurológico es normal.

Temblor de la enfermedad de Parkinson: El temblor es de reposo y desaparece/disminuye al tomar un objeto, con frecuencia baja (2 a 3 movimientos por segundo), y pareciera que "cuenta monedas".

Temblor del síndrome cerebeloso: El temblor es un temblor de intención (dismetría), que solo aparece al realizar movimientos y desaparece del todo con el reposo. Está asociado a gran descoordinación.

PATOLOGÍA DEL NERVO PERIFÉRICO

Todas estas patologías pueden tener tanto compromiso motor, como sensitivo. El compromiso motor es de tipo de segunda motoneurona.

Síndrome de Guillain Barré

También se llama poliradiculoneuritis desmielinizante. Se caracteriza por una tetraparesia, flácida (con disminución del tono muscular) y arrefléctica (con abolición de los ROT).

- * Suele ser de curso subagudo, instalándose en algunos días, terminando con parálisis de los músculos respiratorios, si no es manejado a tiempo.
- * Puede tener síntomas sensitivos (también se desmielinizan los nervios sensitivos), como dolor neuropático e hipoestesia.
- * Además es causa de parálisis facial bilateral.
- * Puede venir precedido de alguna infección (es autoinmune, postinfeccioso), en especial diarreas (por *Campilobacter*).

Síndrome de Miller Fischer o Neuropatía craneal múltiple

Es muy similar al Guillain Barré (también es desmielinizante), pero afecta principalmente a los nervios craneales (no solo al facial, sino a cualquiera, desde el III al XII).

Polineuropatía

Suele estar asociado a diabetes mellitus o otras enfermedades (porfiria, déficit de Vitaminas del complejo B, etc.).

- * Tiene compromiso sensitivo, de predominio distal (en guante y calcetín) y frecuentemente simétrico (ya que se afectan todos los nervios, con mayor afectación de los nervios más largos), con mayor compromiso de la sensibilidad termalgésica y vibratoria.
- * Además puede tener dolor neuropático, de tipo urente, con alodinia.
- * Suele ser de curso crónico, de aparición y evolución en meses.

Mononeuritis múltiple

Está estrechamente relacionado a vasculitis de vaso pequeño (PAM, Wegener y vasculitis secundarias: artritis reumatoide, lupus). Suele tener compromiso motor (paresia y arreflexia) y sensitivo (hipoestesia). El compromiso es asimétrico, ya que afecta a algunos nervios y raíces nerviosas y mantiene indemnes a otros.

SÍNDROMES MEDULARES

Para entender la semiología de los síndromes medulares es necesario recordar la anatomía:

- **Sustancia gris:** está en la zona central de la médula y tiene forma de mariposa, con astas anteriores (motoras) y posteriores (sensitivas). El daño de la sustancia gris solo produce compromiso de la zona afectada y no hacia proximal, ni distal (Ej. se lesiona el asta posterior a nivel de L1, solo producirá anestesia de esa raíz).
- **Sustancia blanca:** Está en la zona periférica de la médula y contiene los tractos que llevan información entre el encéfalo y la médula. La lesión en la sustancia blanca produce afectación desde el nivel de la lesión, hacia distal (Ej. se lesiona la sustancia blanca, a nivel de L1, habrá compromiso desde L1 hasta S4). Los principales tractos son:
 - **Haz corticoespinal:** Hay uno en la zona anterior y otro lateral. Tienen la información motora. Se decusa en el bulbo, por lo que el compromiso es ipsilateral. Es importante recordar que en general se produce un síndrome piramidal o de primera motoneurona.
 - **Haz espinotalámico lateral:** Está en la zona lateral de la médula. Tiene la información sensitiva termalgésica y táctil gruesa. Se decusa en la médula misma (por la comisura anterior), por lo que el compromiso es contralateral.
 - **Cordones posteriores** (también se llaman Gracillis y Cuneatus o Haz de Goll y Brudach): Están en la zona posterior de la médula. Tienen la sensibilidad táctil fina, vibratoria y propioceptiva. Se decusa en el bulbo, por lo que el compromiso es ipsilateral.

Sección medular completa

Produce compromiso motor y sensitivo desde el nivel hacia distal y además puede presentar shock medular, con hipotensión y bradicardia. Según la altura de la lesión, puede variar la clínica:

- * Bajo T1: Solo afecta las extremidades inferiores.
- * Bajo C5: Además afecta las extremidades superiores.
- * Sobre C5: Además se produce parálisis frénica.

Hemisección medular o Sd. de Brown Sequard

Dado el nivel de decusación, se produce lo siguiente:

- Compromiso motor ipsilateral.
- Compromiso sensitivo ipsilateral para la sensibilidad vibratoria, táctil fina y propioceptiva.
- Compromiso sensitivo contralateral para la sensibilidad termalgésica.

Síndrome de arteria espinal anterior

- Se afectan la parte motora (corticoespinal) y la sensitiva termalgésica (espinotalámico lateral).

Síndrome de arteria espinal posterior

- Se afecta la parte sensitiva vibratoria, táctil fina y propioceptiva (cordones posteriores).

Degeneración combinada subaguda

- Se asocia a déficit de vitamina B12.
- Se afecta la parte motora (corticoespinal) y la sensitiva vibratoria, táctil fina y propioceptiva (cordones posteriores).

Síndrome del cono medular

- Afecta las raíces S2 a S4, que dan origen al nervio pudendo y a la fibras parasimpáticas.
- Produce anestesia perineal (en silla de montar), incontinencia urinaria o fecal, vejiga neurogénica, disfunción sexual.

Síndrome de cauda equina

- Tiene compromiso asimétrico de las raíces L1 a S4, por lo que afecta tanto las extremidades inferiores (paresia, hipoestesia, abolición de ROT), como a la parte perineal (en esto puede ser igual al síndrome del cono medular: disfunción sexual, incontinencia, anestesia en silla de montar, etc).

Dr. Guillermo Guevara A.

- A diferencia de todas las demás, el compromiso motor es de segunda motoneurona, con hiporreflexia e hipotonía.

Siringomielia

Se produce dilatación del conducto del epéndimo, afectando primeramente la comisura anterior, luego la sustancia gris y finalmente la sustancia blanca. Por eso mismo, presenta la siguiente clínica, en el siguiente orden de aparición:

- 1) Afectación de la sensibilidad termalgésica a determinado nivel, sin afectación distal (comisura anterior: por ahí se decusa la información termalgésica).
- 2) Afectación sensitiva y motora a determinado nivel, sin afectación distal (compromiso de la sustancia gris).
- 3) Afectación sensitiva y motora hacia distal (compromiso de la sustancia blanca).

PATOLOGÍA DE NERVIOS CRANEALES

- **Nervio olfatorio (I):** Hiposmia o anosmia (no siente olor).
- **Nervio óptico (II):** Amaurosis (no ve por un ojo), con defecto pupilar aferente (también se llama pupila de Marcus Gunn o escape pupilar).
- **Nervio oculomotor (III):** Imposibilidad de mirar hacia medial, arriba y abajo. Además suele tener ptosis, anisocoria con midriasis y estrabismo divergente (porque el VI nervio desvía el ojo).
- **Nervio troclear (IV):** Imposibilidad de mirar hacia inferomedial. Afecta especialmente para bajar escaleras. Puede haber un ligero estrabismo divergente.
- **Nervio trigémino (V):** Anestesia de la hemicara. Alteración del reflejo corneal (vía aferente). Además puede haber debilidad para la masticación (los músculos masticatorios son inervados por el trigémino).
- **Nervio abducens (VI):** Imposibilidad de mirar hacia lateral, con estrabismo convergente.
- **Nervio facial (VII):** Imposibilidad de mover los músculos de la expresión facial de una hemicara (si puede arrugar la frente o cerrar el ojo es sugerente de AVE u otra causa de parálisis facial central). Además por alteración de la rama "cuerda del tímpano", puede tener disgeusia (alteración del gusto), hiperacusia, dolor retroauricular, anestesia en el trago. No se afecta la masticación (trigémino). También se afecta el reflejo corneal (vía eferente).
- **Nervio auditivo (VIII):** Hipoacusia de tipo sensorineural (puede tener tinitus) y vértigo periférico (nistagmo horizontal, lateropulsiones hacia el lado afectado, disminución del vértigo al fijar la mirada y ausencia de signos cerebelosos).
- **Nervio glosofaríngeo (IX):** Dificultades para tragar, disgeusia y desviación de la úvula hacia el lado afectado.
- **Nervio vago (X):** Se afecta el sistema parasimpático, por lo que hay taquicardia, hipertensión, disgeusia, constipación y disminución de los movimientos peristálticos.
- **Nervio espinal accesorio (XI):** Inerva los músculos trapecio y esternocleidomastoideos, por lo que se produce paresia de dichos músculos.
- **Nervio hipogloso (XII):** Imposibilidad de mover la lengua y desviación de la lengua hacia el lado afectado.
- * **Lesión del fascículo longitudinal medial:** Imposibilidad de mirar hacia medial, asociado a nistagmo.
- * **Síndrome de Horner:** Miosis, ptosis, enoftalmo y anhidrosis de la hemicara.
- * **Inervación de la lengua:** Sensibilidad táctil (V), movimiento (XII) y sabor (VII, IX y X).

Dr. Guillermo Guevara A.

ACCIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO (AVE o ACV)

Se caracteriza por aparición de signos focales, de inicio ictal (súbito). Dentro de los signos focales se comprende la hemiparesia, hemihipoestesia, afasia, afectación de pares craneanos, vértigo central, etc. Es importante recordar que la afectación motora es de tipo piramidal o de primera motoneurona.

AVE hemorrágico

Suele presentar cefalea, seguida de aparición de signos focales y finalmente puede evolucionar a un síndrome de hipertensión endocraneana (cefalea, vómitos y edema de papila), terminando con un síndrome de enclavamiento, en los casos más graves.

AVE isquémico por afectación de arteria cerebral media (ACM)

Suele presentar hemiparesia e hemihipoestesia, de predominio braquial (afecta más la extremidad superior), contralateral a la lesión (se decusa más abajo, en el bulbo). Además, en el caso de la afectación de la ACM izquierda, suele producirse afasia (motora y/o sensitiva).

AVE isquémico por afectación de arteria cerebral anterior (ACA)

Irriga la parte mesial del cerebro (la que está dentro de la cisura sagital), que corresponde a la extremidad inferior, en los homúnculos motor y sensitivo.

- Por ello, suele tener hemiparesia e hemihipoestesia de predominio crural (afecta más la extremidad inferior).
- Además el compromiso motor suele ser mayor que el sensitivo.
- Suele tener además compromiso cognitivo (por afectación del lóbulo frontal), con desorientación, mutismo, etc.

AVE isquémico por afectación de arteria cerebral posterior (ACP)

También irriga la parte mesial del cerebro.

- Por ello, también tiene hemiparesia e hemihipoestesia de predominio crural.
- Pero la afectación sensitiva suele ser mayor a la motora (la corteza sensitiva está posterior a la motora).
- Suele tener además defectos del campo visual (por compromiso del lóbulo occipital).

AVE lacunar

La clínica puede variar mucho entre las distintas lesiones. Las más habituales son 1. hemiparesia pura, 2. hemihipoestesia pura, 3. hemiparesia + hemihipoestesia, 4. disartria (habla como borracho) + hemiparesia. Todo esto puede ser indistinguible de un AVE no lacunar, pero es característico que los síntomas reviertan en algunos días y dejen muy escasas secuelas.

Accidente isquémico transitorio (AIT o TIA, por sus siglas en inglés)

Tiene clínica de AVE, pero transitoria, de algunos minutos de duración, revirtiendo completamente, de manera espontánea. Por definición, duran menos de 24 horas, pero en la práctica suelen durar solo algunos minutos.

Síndrome alterno

Se produce afectación de uno o más pares craneanos, con compromiso hemiparesia o hemihipoestesia contralateral. Se debe a afectación del troncoencéfalo, que contiene los núcleos de los pares craneanos y también los tractos nerviosos que se decusan más abajo (por eso la afectación de las extremidades es contralateral).

Afasia motora o expresiva o de Broca

Es por compromiso del lóbulo frontal. Tiene imposibilidad de hablar y de escribir, pero sí entiende lo que escucha y lo que lee.

Dr. Guillermo Guevara A.

Afasia sensitiva o de comprensión o de Wernicke

Es por compromiso parietal y temporal. Tiene imposibilidad de entender lo que escucha y no puede leer. Sí puede hablar y escribir.

Afasia mixta

Mezcla síntomas de las dos anteriores.

Afasia de conducción

No se afecta la corteza cerebral, sino los tractos que unen las áreas de Broca y de Wernicke (fascículo arqueado). Clínicamente puede ser muy similar a una afasia mixta, de predominio motor. La principal característica es que no son capaces de repetir lo que escuchan.

Afasia transcortical motora o dinámica

Se afecta la corteza prefrontal izquierda. Clínicamente es muy similar a una afasia motora, pero con una gran diferencia: son capaces de repetir.

Enclavamientos

Se dan en contexto de un síndrome de hipertensión endocraneana grave y es generalmente fatal, si no se interviene quirúrgicamente. Hay dos tipos más importantes:

- Transtentorial o del uncus del temporal: Se hernia el uncus del lóbulo temporal, a través del tentorio y comprime el mesencéfalo. Por ello produce compromiso del III nervio craneal ipsilateral (midriasis, ptosis y estrabismo divergente), hemiparesia contralateral y compromiso de conciencia.
- Transforaminal o de las amígdalas cerebelosas: Se hernian las amígdalas cerebelosas, a través del foramen magno y se comprime el bulbo raquídeo. Se produce hemiparesia, compromiso de conciencia y compromiso del centro respiratorio, con hipoventilación e insuficiencia respiratoria.

ESCLEROSIS MÚLTIPLE

Es una enfermedad autoinmune. Se debe a desmielinización de la sustancia blanca del SNC, por lo que afecta al cerebro, troncoencéfalo y médula espinal. Además afecta al nervio óptico, porque tiene mielina central.

- * Cursa en brotes, con instalación en algunos días.
- * Puede dejar secuelas o revertir parcialmente o por completo, dependiendo del tratamiento y del tipo de afectación.
- * Los síntomas más frecuentes son hemiparesia, hemihipoestesia, amaurosis (neuritis óptica), pero también puede producir todo tipo de signos focales (ej. incontinencia urinaria).
- * Generalmente no tiene afasia, porque no afecta la sustancia gris (corteza cerebral), sino solo la sustancia blanca (la excepción es la afasia de conducción, que sí puede tener).

MIELITIS TRANSVERSA

Suele ser autoinmune. Se caracteriza por un síndrome medular de instalación en pocos días u horas: por regla general se presenta como una sección medular completa. Suele estar precedida por dolor dorsal, en la zona de inflamación. En la etapa aguda puede presentarse como una tetraparesia flácida y arrefléctica (igual que el Sd. de Guillain Barré), pero la mielitis transversa afecta más a los esfínteres y suele presentar un nivel sensitivo. Además, suele ser más una paraparesia que una tetraparesia.

CEFALEAS

Jaqu coasta o migraña o cefalea vascular

La cefalea es pulsátil u opresiva, de localización fronto-parietal, siendo habitualmente mayor en una mitad de la cabeza (hemicránea). También suele ser de localización retro-ocular.

- * Es frecuente que venga asociada a aura, que es una síntoma distinto al dolor y transitorio. El aura más frecuente son los escotomas centelleantes (visión de luces), aunque puede ser cualquier otro síntoma (ej. hipoestesia, hormigueo o la simple sensación de que habrá dolor de cabeza o incluso aparición de signos focales: afasia, hemiparesia, etc). El aura suele preceder al dolor de cabeza (lo que permite a tomar analgésicos antes de que empiece), pero puede iniciar simultáneamente o con posterioridad a la cefalea.
- * Suele empeorar con la luz (fotofobia), con los ruidos (sonofobia) y con el ejercicio.
- * Suele mejorar al dormir y estar en un cuarto oscuro y silencioso.

Cefalea tensional

Suele ser opresiva, de localización occipital y temporal (en cintillo), siendo mayor en la tarde.

- * Es frecuente que se irradie al cuello y que haya dolor a la palpación de los músculos cervicales posteriores.

Cefalea mixta

Mezcla síntomas de la jaqu coasta y la cefalea tensional.

Cluster o cefalea en racimos

Es una cefalea muy intensa, cíclica, que aparece en brotes, que pueden durar desde pocos días a algunas semanas. En cada brote se produce dolor de pocos minutos de duración, pero muy intenso y suele repetirse varias veces al día (muchas veces a la misma hora).

- * El dolor es de localización periocular.
- * Además puede tener distintas alteraciones: ojo rojo superficial, miosis (a diferencia del galucoma agudo que tiene midriasis y ojo rojo profundo), ptosis (similar a un Síndrome de Horner: ptosis, miosis), epifora y rinorrea.

Neuralgia primarias y secundarias

Suelen tener dolor tipo eléctrico, o en ramalazo, de segundos de duración, que puede ser muy doloroso. El dolor se suele gatillar con estímulos, como el tacto o el roce en el lugar afectado.

- * Las neuralgias primarias se caracterizan por tener solo dolor, sin alteraciones en el examen neurológico (sin hipoestesia, ni alteración de reflejos).
- * Las neuralgias secundarias (a un tumor por ejemplo) sí tienen alteración del examen neurológico, con hipoestesia, alteración de los reflejos u otros signos focales.

Neuralgia del trigémino: El dolor está localizado en la cara, afectando una o más de las 3 ramas del trigémino: Nasociliar o V1: frente; Maxilar o V2: mejilla, labio superior y arcada dental superior; Mandibular o V3: mandíbula y arcada dental inferior.

Neuralgia del glosofaríngeo: Duele la garganta y se gatilla al tragar.

Neuralgia de Arnold: El dolor está en la zona retroauricular y occipital.

Neuralgia postherpética: El dolor afecta los mismos dermatomas que fueron previamente afectados por un herpes zóster.

Hemorragia subaracnoidea (HSA)

Suele presentar dolor de inicio súbito (cefalea ictal), muy intenso (el más intenso de la vida).

- * Además puede tener síntomas de hipertensión endocraneana (vómitos, compromiso de conciencia) y pueden aparecer signos meníngeos (rigidez de nuca, Brudzinsky y Kerning).
- * Además puede cursar con fiebre y convulsiones (se diferencia de la meningitis, porque la HSA tiene inicio súbito).
- * En algunos casos puede haber signos focales, pero estos son raros y solo se ven cuando se inyecta la sangre, produciendo un hematoma intracerebral, similar a un AVE hemorrágico.

Dr. Guillermo Guevara A.

Tumor cerebral

Se caracteriza por la triada de: 1) síndrome de hipertensión endocraneana (cefalea matinal, náuseas y vómitos y edema de papila), 2) signos focales y 3) convulsiones (habitualmente crisis parciales, pero podrían parecer generalizadas).

Absceso cerebral

La clínica es igual al tumor cerebral, pero se suma fiebre.

EPILEPSIA

No se debe confundir la epilepsia (la enfermedad), con las crisis epilépticas (los síntomas). La epilepsia se caracteriza por aparición de crisis recurrentes, de inicio ictal y estereotipadas (son similares entre ellas). Después de la crisis es posible que presente déficit neurológico transitorio (parálisis de Todd: se confunde con TIA, pero es postconvulsivo).

Epilepsias Primarias

Se inician en la infancia y solo tienen crisis de tipo generalizada.

Epilepsias focales

Se caracterizan por tener crisis parciales, ya sean simples o complejas o secundariamente generalizadas. Son más frecuentes en los adultos (por cualquier lesión focal: tumor cerebral, AVE, etc.), pero también pueden presentarse en los niños.

Crisis epilépticas generalizadas

- Tónico-clónica: Se produce una fase tónica, con flexión de las extremidades superiores y extensión de las extremidades inferiores, asociado a compromiso de conciencia. Luego sigue una fase clónica, con movimientos rítmicos de las 4 extremidades.
- Tónica: Solo tiene la fase tónica.
- Atónica: Se pierde el tono muscular, súbitamente. Puede ser desde un simple "cabeceo" (con pérdida del tono de la cabeza de menos de 1 segundo de duración), hasta caídas igual a un síncope. Estas últimas suelen asociarse a relajación de esfínteres.
- Mioclónica: Se producen mioclonías generalizadas, que son una especie de "saltito" de todo el cuerpo. Luego presentan convulsiones tónico clónicas. Se exagera con las pantallas.
- Ausencia: El paciente se desconecta del medio por algunos segundos y no recuerda el episodio.

Crisis epilépticas focales

- Parcial simple: La clínica varía mucho, desde movimientos de una extremidad a percepción de algún estímulo (sensitivo, visual, olfatorio) o bien dolor abdominal y vómitos.
- Parcial compleja: Además de lo anterior, presenta desconexión del medio (es lo que diferencia la simple de la compleja). Las más características son las del lóbulo temporal: "crisis psicomotoras".
- Parcial secundariamente generalizada: Empieza como una crisis parcial simple o compleja y luego evoluciona a una crisis tónico-clónica u otro tipo de crisis generalizada.